

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP)		
	No. Dokumen 004.10/I-SPO/DIR/I/2026	No. Revisi 01	Halaman 01
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 03 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur RS Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	1. Keselamatan pasien/<i>patient safety</i> adalah pasien bebas dari cedera yang tidak seharusnya terjadi atau bebas dari cedera yang potensial akan terjadi (penyakit, cedera fisik/sosial/psikologis, cacat, kematian, dll) terkait dengan pelayanan kesehatan. 2. Insiden Keselamatan Pasien yang selanjutnya disebut Insiden, adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. 3. Kejadian Potensial Cedera Signifikan (KPCS) merupakan kondisi (selain dari proses penyakit atau kondisi pasien itu sendiri) yang berpotensi menyebabkan kejadian sentinel. 4. Kejadian Nyaris Cedera (KNC): merupakan insiden keselamatan pasien yang belum terpapar pada pasien. 5. Kejadian Tidak Cedera (KTC): merupakan insiden keselamatan pasien yang sudah terpapar pada pasien namun tidak menyebabkan cedera. 6. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD): merupakan insiden keselamatan pasien yang menyebabkan cedera pada pasien. 7. Kejadian Sentinel merupakan kejadian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit pasien atau penyakit yang mendasarinya yang terjadi pada pasien yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang bersifat sementara/reversible. 8. SIMRS adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, yaitu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses operasional rumah sakit. 9. Grading adalah penilaian risiko suatu insiden yang akan menentukan tindakan yang harus dilakukan terhadap insiden tersebut.		
Tujuan	1. Terlaksananya sistem pencatatan dan pelaporan insiden keselamatan pasien 2. Diketuainya penyebab insiden keselamatan pasien sampai pada akar masalah 3. Untuk memperoleh data/angka insiden keselamatan pasien 4. Upaya pencegahan terjadinya kejadian/insiden keselamatan pasien berikutnya 5. Didapatkannya pembelajaran untuk perbaikan asuhan kepada pasien		
Kebijakan	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023;		

	3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 4. Keputusan Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan No.HK.02.02/D/43961/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit; 6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang Nomor: 004.2/I-PDM/KMKP/I/2026 Tentang Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.
Prosedur	1. Apabila terjadi suatu insiden (KNC/KTD/KPC) di lingkungan Rumah Sakit, petugas wajib segera menindaklanjuti (ditangani) untuk mengurangi dampak atau akibat yang tidak diharapkan. 2. Setelah menindaklanjuti, petugas yang mengetahui insiden tersebut segera membuat laporan insidennya dengan mengisi formulir insiden (terlampir) pada akhir kerja/shift kepada kepala ruangan (paling lambat 2x24 jam), diharapkan tidak menunda laporan. 3. Setelah mengisi form laporan, petugas segera menyerahkan kepada kepala ruang. 4. Kepala ruang memeriksa laporan insiden yang diberikan petugas, dan melakukan grading risiko terhadap insiden yang dilaporkan. 5. Hasil grading akan menentukan bentuk investigasi dan analisis yang dilakukan sebagai berikut: a. Warna biru : Investigasi sederhana oleh atasan langsung (kepala instalasi/kepala unit/kepala bidang), dengan waktu tidak melebihi 7 (tujuh) hari. b. Warna hijau: Investigasi sederhana oleh atasan langsung (kepala instalasi/kepala unit/kepala bidang) dengan waktu tidak melebihi 14 (empat belas) hari. c. Warna kuning: Investigasi komprehensif/RCA oleh Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, dengan waktu maksimal 45 hari. d. Warna merah: Investigasi komprehensif/RCA oleh Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, dengan waktu maksimal 45 hari 6. Laporan juga dimasukkan dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) (langkah melakukan penginputan laporan pada SIMRS terlampir). 7. Setelah selesai melakukan investigasi sederhana, laporan hasil investigasi dan laporan insiden akan dilaporkan kepada Sub Komite Keselamatan Pasien RS. 8. Sub Komite Keselamatan Pasien RS akan melakukan regrading melalui analisis kembali hasil investigasi dan laporan insiden untuk menentukan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan (komprehensif/RCA). 9. Setelah melakukan regrading, untuk hasil grading Kuning/Merah akan dilakukan Investigasi komprehensif/RCA oleh Sub Komite Keselamatan Pasien RS. 10. Setelah melakukan investigasi komprehensif/RCA, Komite PMKP akan membuat laporan dan rekomendasi untuk “perbaikan” serta “pembelajaran” berupa : petunjuk / <i>safety alert</i> untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali. 11. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien memberikan rekomendasi pembelajaran untuk mencegah kejadian berulang dan mengirimkan hasil rekomendasi

	kepada direktur. 12. Direktur kemudian memberikan tanggapan dari rekomendasi/kebijakan. 13. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien memberikan feedback dengan menyampaikan hasil rekomendasi pembelajaran kepada unit dan menuliskan hasil rekomendasi di SIMRS. 14. Komite Mutu melaporkan IKP Sentinel dan KTD kepada Kementerian Kesehatan melalui https://mutufasyankes.kemkes.go.id.
Unit Terkait	Seluruh Unit Kerja Rumah Sakit

Lampiran

1. Formulir Laporan Insiden ke Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien RS (Internal)

Formulir Laporan Insiden Internal

NO. IKP :

RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOCOPY, DILAPORKAN MAXIMAL 2 x 24 JAM

LAPORAN INSIDEN
(INTERNAL)

I. DATA PASIEN

Nama :
No. RM :
Ruangan :
Umur * :
Jenis kelamin :
Penanggung biaya pasien :
Tanggal Masuk Ruangan :

☐ 0-1 bulan
☐ > 1 tahun – 5 tahun
☐ > 15 tahun – 30 tahun
☐ > 65 tahun (76 Tahun)

☐ > 1 bulan – 1 tahun
☐ > 5 tahun – 15 tahun
☐ > 30 tahun – 65 tahun

☐ Laki-laki
☐ Perempuan

☐ Pribadi
☐ BPJS

☐ Asuransi Swasta
☐ Lainnya (sebutkan)

II. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden

TANGGAL/ JAM	KRONOLOGI	KETERANGAN (bisa diisi foto/ bukti-bukti)

Simpulan :

2. Jenis Insiden* :

☐ Kejadian Potensial Cedera / KPC
☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
☐ Kejadian Tidak Cedera / KTC
☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)
☐ Kejadian Sentinel (Sentinel Event)
3. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*

☐ Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
☐ Pasien
☐ Keluarga / Pendamping pasien

-
- ☐ Pengunjung
☐ Lain-lain(sebutkan)
4. Insiden terjadi pada* :
☐ Pasien
☐ Lain-lain(sebutkan)
Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3RS.
5. Insiden menyangkut pasien :
☐ Pasien rawat inap
☐ Pasien rawat jalan
☐ Pasien UGD
☐ Lain-lain(sebutkan)
6. Tempat Insiden
(Tempat pasien berada)
7. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
☐ Anak dan Subspesialisasinya
☐ Bedah dan Subspesialisasinya
☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
☐ THT dan Subspesialisasinya
☐ Mata dan Subspesialisasinya
☐ Saraf dan Subspesialisasinya
☐ Anastesi dan Subspesialisasinya
☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
☐ Jantung dan Subspesialisasinya
☐ Paru dan Subspesialisasinya
☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
☐ Lain-lain Urologi
8. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden:
9. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
☐ Kematian
☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
☐ Cedera Ringan
☐ Tidak ada cedera
10. Tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian, dan hasilnya :
11. Tindakan dilakukan oleh* :
☐ Tim, terdiri dari :
☐ Dokter
☐ Perawat
☐ Petugas lainnya
12. Apakah kejadian yang sama pernah terjadi di Unit Kerja lain?*
- ☐ Ya ☐ Tidak
- Apabila Ya, isi bagian dibawah ini.
- Kapan ? dan Langkah / tindakan apa yang telah diambil pada Unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama?**
-
-
-

Pembuat Laporan	:	Penerima Laporan	:
Paraf	:	Paraf	:
Tgl Lapor	:	Tgl terima	:

Grading Risiko Kejadian* (Diisi oleh atasan pelapor) :
☐ **BIRU** ☐ **HIJAU** ☐ **KUNING** ☐ **MERAH**
 NB. * = pilih satu jawaban

III. **TIPE INSIDEN**

No.	Tipe Insiden	Subtipe Insiden	
1.	Administrasi Klinik	a. Proses	1. Serah terima 2. Perjanjian 3. Daftar tunggu/ antrian 4. Rujukan/ konsultasi 5. Admisi 6. Keluar/ pulang dari RS 7. Pindah perawatan (<i>Transfer of care</i>) 8. Identifikasi pasien 9. <i>Consent</i> 10. Pembagian tugas 11. Respons terhadap kegawatdaruratan
		b. Masalah	1. Tidak <i>performed</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pelayanan
2.	Proses/ Prosedur Klinis	a. Proses	1. Skrining/ pencegahan/ <i>medical check up</i> 2. Diagnosis/ <i>assessment</i> 3. Prosedur/ pengobatan/ intervensi 4. <i>General care/ management</i> 5. Tes/ investigasi 6. Spesimen/ hasil 7. Belum dipulangkan (<i>detention/ restraint</i>)
		b. Masalah	1. Tidak <i>performance</i> ketika dibutuhkan/ indikasi 2. Tidak lengkap/ inadekuat 3. Tidak tersedia 4. Salah pasien 5. Salah proses/ pengobatan/ prosedur 6. Salah bagian tubuh/ sisi
3.	Dokumentasi	a. Dokumen yang terkait	1. Order/ permintaan 2. <i>Chart</i> / rekam medik/ <i>assessment/</i> konsultasi 3. <i>Checklist</i> 4. Form/ sertifikat 5. Instruksi/ informasi/ kebijakan/ SPO/ <i>Guideline</i> 6. Label/ stiker/ identifikasi <i>bands</i> / kartu 7. Surat/ e-mail/ rekaman komunikasi 8. Laporan/ hasil/ <i>images</i>
		b. Masalah	1. Dokumen hilang/ tidak tersedia 2. Terlambat mengakses dokumen 3. Salah dokumen/ salah orang

			4. Tidak jelas/ membingungkan/ <i>illegible</i>
4.	Infeksi Nosokomial (HAIs)	a. Tipe organisme	1. Bakteri 2. Virus 3. Jamur 4. Parasit 5. Protozoa 6. Rickettsia 7. Prion/ partikel protein yang infeksius 8. Organisme tidak teridentifikasi
		b. Tipe/ Bagian infeksi	1. <i>Bloodstream</i> 2. Bagian yang dioperasi 3. Abses 4. Pneumonia 5. Kanul IV 6. Protesis infeksi 7. Drain/ tube urin 8. Jaringan lunak
5.	Medikasi/ cairan Infus	a. Medikasi/ Cairan infus yang terkait	1. Daftar Medikasi 2. Daftar Cairan infus
		b. Proses penggunaan medikasi/ Cairan infus	1. Peresepan 2. Persiapan/ <i>dispensing</i> 3. Pemaketan 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. <i>Supply/</i> pesan 7. Penyimpanan 8. Monitoring
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah obat
			1. Salah dosis/ kekuatan/ frekuensi 2. Salah formulasi/ presentasi 3. Salah rute pemberian 4. Salah jumlah/ kuantitas 5. Salah <i>Dispensing</i> Label/ instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. <i>Omitted medicine or dose</i> 9. Obat kadaluarsa 10. Adverse drug reaction (reaksi efek samping obat)
6.	Transfusi darah/ Produk darah	a. Transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Produk selular 2. Faktor pembekuan (<i>clotting</i>) 3. Albumin/ plasma protein 4. Imunoglobulin
		b. Proses transfusi darah/ Produk darah terkait	1. Tes pre transfusi 2. Peresepan 3. Persiapan/ <i>dispensing</i> 4. Pengantaran 5. Pemberian 6. Penyimpanan 7. Monitoring 8. Presentasi/ pemaketan 9. <i>Supply/</i> pesan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah darah/ produk darah 3. Salah dosis/ frekuensi 4. Salah jumlah 5. Salah label <i>dispensing/</i> Instruksi 6. Kontraindikasi 7. Salah penyimpanan 8. Obat atau dosis yang diabaikan 9. Darah kadaluarsa

			10. Efek samping/ <i>adverse effect</i>
7.	Nutrisi	a. Nutrisi yang terkait	1. Nutrisi umum 2. Nutrisi khusus
		b. Proses nutrisi	1. Peresepan/ permintaan 2. Pesiapan/ manufaktur/ memasak 3. <i>Supply</i> / pesan 4. Penyajian 5. <i>Dispensing</i> / alokasi 6. Pengantaran 7. Pemberian 8. Penyimpanan
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah diet 3. Salah jumlah 4. Salah frekuensi 5. Salah konsistensi
8.	Oksigen/ Gas	a. Oksigen/ Gas terkait	Daftar oksigen /gas terkait
		b. Proses penggunaan oksigen/ Gas	1. Label silinder/ warna kode/ <i>index pin</i> 2. Peresepan 3. Pemberian 4. Pengantaran 5. <i>Supply</i> / order
		c. Masalah	1. Salah pasien 2. Salah gas 3. Salah <i>rate/ flow</i> / konsentrasi 4. Salah mode pengantaran 5. Kontraindikasi 6. Salah penyimpanan 7. Gagal pemberian 8. Kontaminasi
9.	Alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	a. Tipe alat medis/ Alat kesehatan/ <i>Equipment property</i>	Daftar alat medis/ alat kesehatan/ <i>equipment property</i>
		b. Masalah	1. Presentasi/ pemaketan tidak baik 2. Ketidaktersediaan 3. <i>Inapropriate for task</i> 4. Tidak bersih/ tidak steril 5. Kegagalan/ malfungsi
10.	Pasien	a. Perilaku pasien	1. Tidak kooperatif 2. Tidak pantas/ sikap bermusuhan/ kasar 3. Berisiko/ sembrono/ berbahaya 4. Masalah dengan penggunaan substansi/ <i>abuse</i> 5. Mengganggu/ <i>harrassment</i> 6. Diskriminasitif / berprasangka 7. Berkeliaran, melarikan diri 8. Sengaja mencederai diri, bunuh diri.
		b. Agresi / <i>Assault</i>	1. Agresi verbal 2. Kekerasan fisik 3. Ancaman nyawa
11.	Jatuh	a. Tipe Jatuh	1. Tersandung 2. Slip 3. Kolaps 4. Hilang keseimbangan
		b. Keterlibatan saat jatuh	1. <i>Velbed</i> 2. Tempat tidur 3. Kursi 4. Strecher 5. Toilet 6. Peralatan terapi

			7. Tangga 8. Dibawa/dibantu oleh orang lain
12.	Kecelakaan	a.Benturan tumpul	1. Kontak dengan benda/binatang 2. Kontak dengan orang 3. Hancur, remuk
		b. Serangantajam/ tusukan	Cakaran, sayatan, tusukan, gigitan, sengatan
		c. Kejadian mekanik lain	1. Benturan akibat ledakan bom 2. Kontak dengan mesin
		d. Peristiwa mekanik lain	
		e. Mekanisme Panas	Panas yang berlebihan, dingin yang berlebihan
		f. Ancaman pada pernafasan	Ancaman mekanik pernafasan, tenggelam atau hampir tenggelam, pembatasan oksigen-kekurangan tempat/ <i>confinement to oxygen-deficient place</i>
		g. Paparan bahan kimia atau substansi lainnya	1. Keracunan bahan kimia atau substansi lain 2. Bahan kimia korosif
		h. Mekanisme spesifik yang lain menyebabkan cedera	1. Paparan listrik/radiasi 2. Paparan suara/ getaran 3. Paparan tekanan udara 4. Paparan karena gravitasi rendah
		i. Paparan karena dampak cuaca, bencana alam	
13.	Infrastruktur/ Bangunan/ Benda lain yang terpasang	Keterlibatan struktur/ bangunan	1. Daftar struktur 2. Daftar bangunan 3. Daftar <i>furniture</i> 4. Inadekuat 5. Damaged/ faulty/ worn
14.	<i>Resource/ Manajemen organisasi</i>	a. Beban kerja manajemen yang berlebihan ketersediaan/ keadekuatan tempat tidur/ pelayanan Sumber Daya Manusia Ketersediaan/ keadekuatan staf Organisasi/ Tim b. <i>Protocols/ Kebijakan/ SOP Guideline</i> c. Ketersediaan/ <i>Adequacy</i>	
15	Laboratorium/ Patologi	Pengambilan/ <i>pick up transport sorting data entry</i> proses verifikasi/ validasi hasil	

1. Penyebab langsung (Direct / Proximate / Immediate Cause)
2. Akar penyebab masalah (underlying - root cause)
3. Rekomendasi / Solusi

NO	AKAR MASALAH	REKOMENDASI/ SOLUSI
----	--------------	---------------------

1		
2		

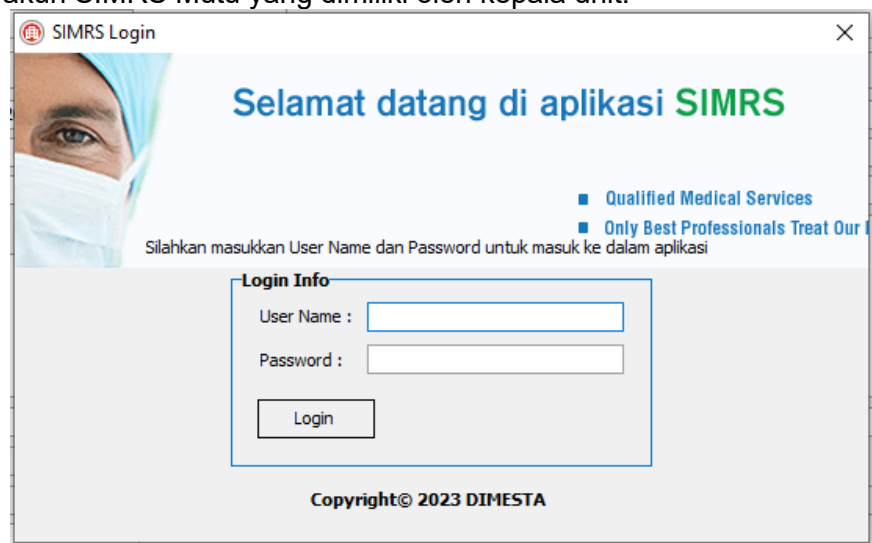
NB.* : Pilih satu jawaban, kecuali bila berpendapat lain

2.Langkah Melakukan Penginputan Laporan di SIMRS

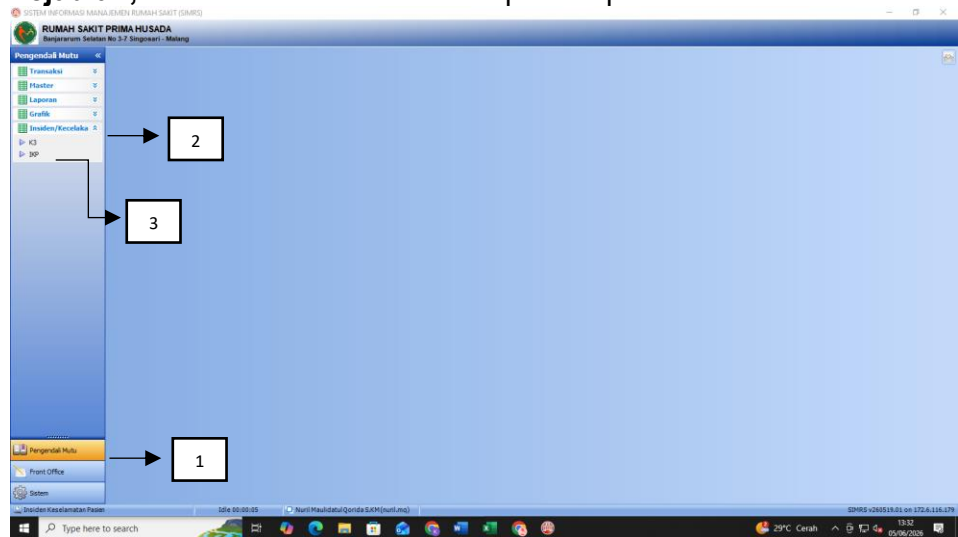
2.1 Pelaporan IKP Internal melalui SIMRS

Selain mengumpulkan form pelaporan IKP kepala ruangan juga wajib melakukan pelaporan IKP melalui billing SIMRS Rumah sakit berikut langkah - langkah pelaporan IKP melalui SIMRS Rumah sakit.

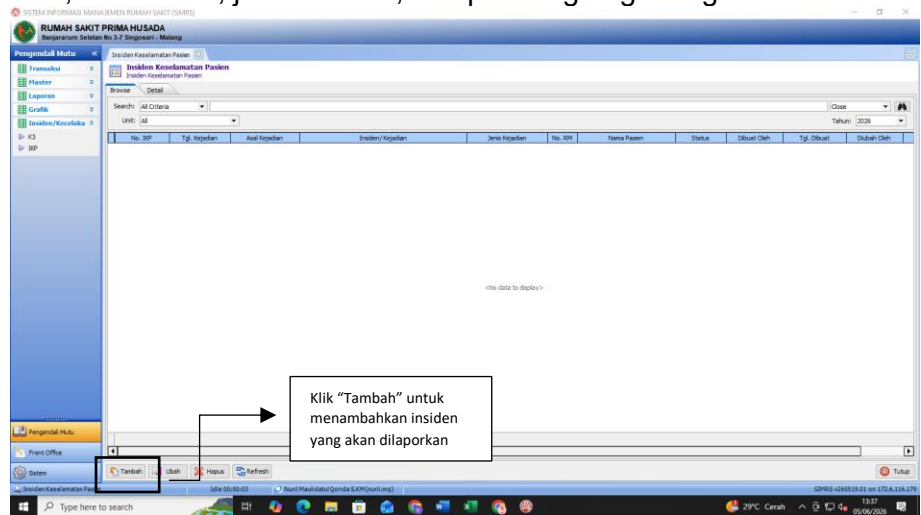
- 1. Lakukan **login ke SIMRS** dengan menggunakan user name & password sesuai dengan akun SIMRS Mutu yang dimiliki oleh kepala unit.



- 2. Setelah berhasil login pada menu **Pengendali Mutu**, klik pada menu **Insiden/Kejadian**, kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

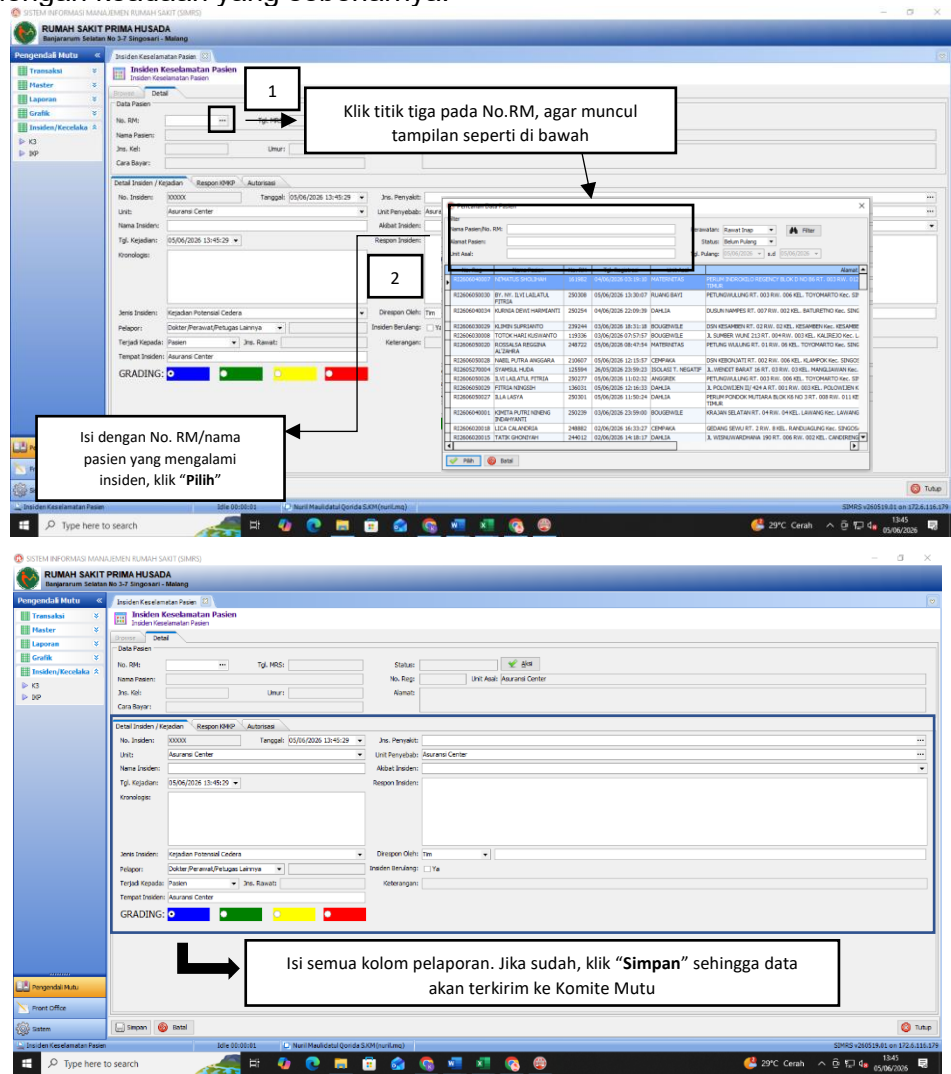


- 3. Selanjutnya, klik “Tambah” dan akan muncul form pelaporan dalam SIMRS berisi nama pasien, nomor RM, jenis insiden, sampai dengan grading insiden.



- 4. Setelah melampirkan nomor RM, seluruh data pasien seperti tanggal MRS, nama pasien, umur, dll akan otomatis terisi. Selanjutnya, lakukan penginputan detail insiden

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

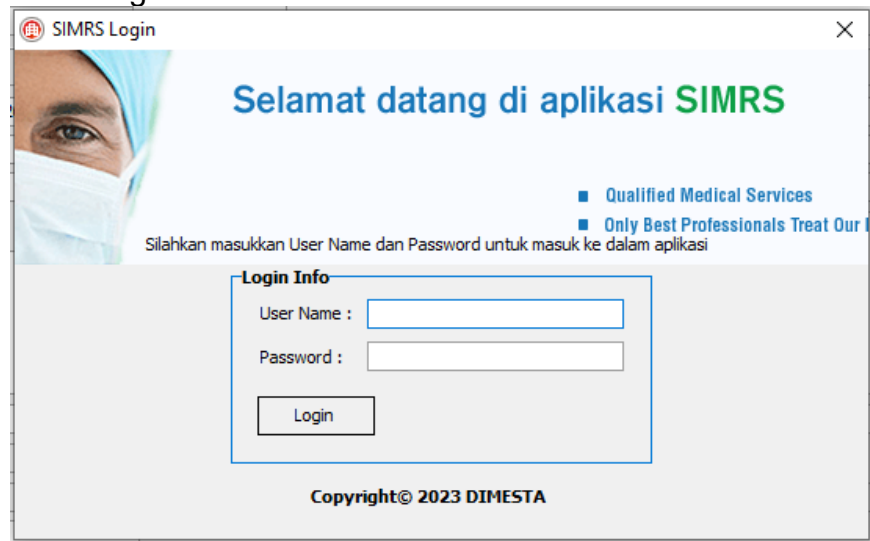


2.2 Respon Komite Mutu – Pelaporan IKP oleh Unit di SIMRS

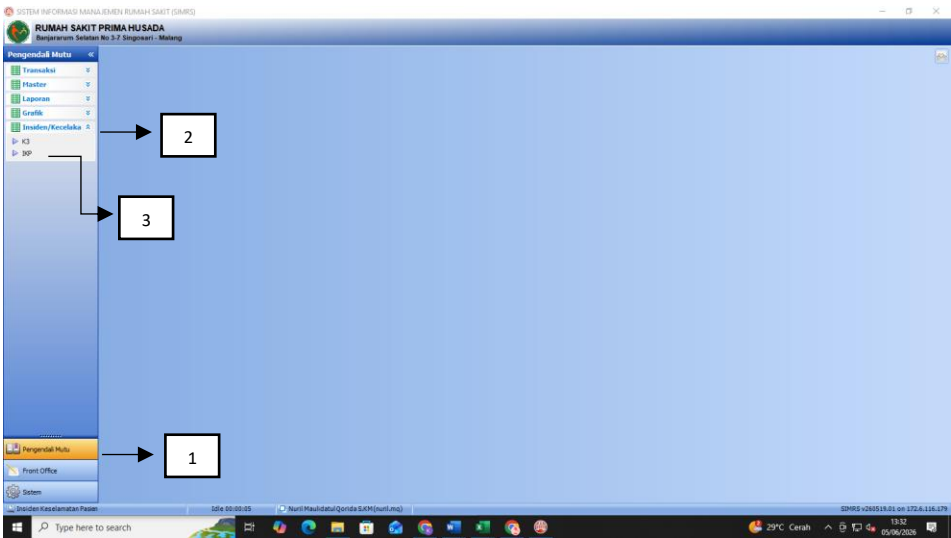
Setelah unit melakukan pelaporan dalam waktu 2x24 jam dan mengkonfirmasi bahwa sudah melaporkan pada billing SIMRS, komite Mutu akan melakukan pengecekan pada SIMRS untuk menindaklanjuti pelaporan tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

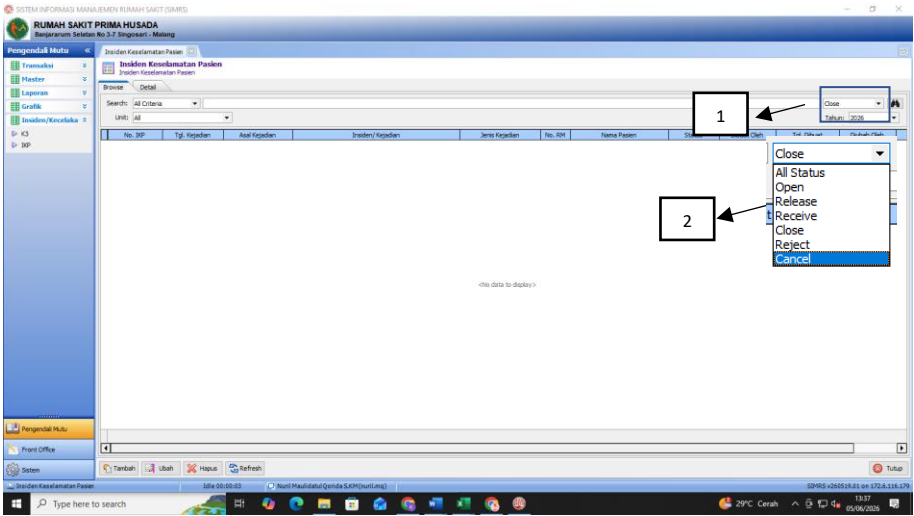
1. Lakukan **login** ke akun SIMRS dengan menggunakan username dan password yang sesuai dengan akun SIMRS.



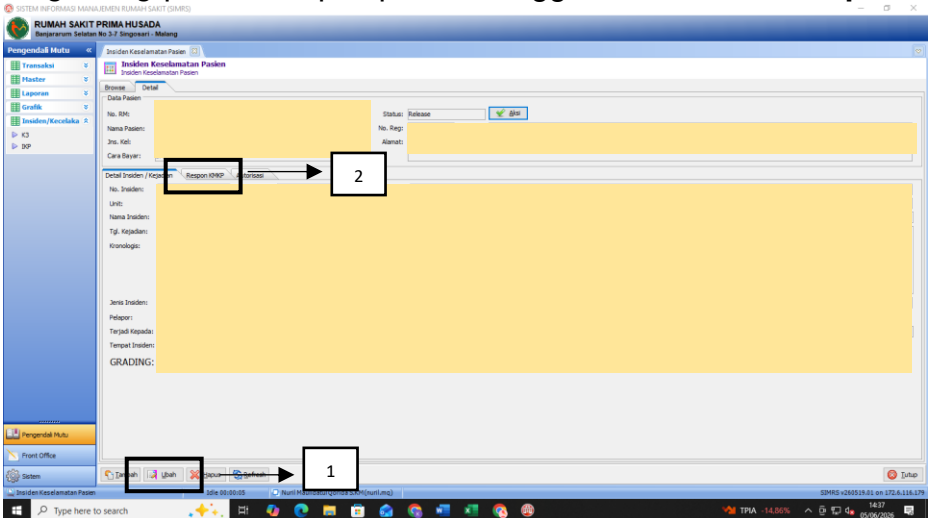
2. Setelah berhasil login pada menu **Pengendali Mutu**, klik pada menu **Insiden/Kejadian**, kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini.



3. Pilih “all criteria” dan “release” untuk melihat insiden yang sudah dilaporkan oleh unit.



4. Klik “Ubah” untuk melihat deskripsi insiden dan menanggapi pelaporan dari unit. Lakukan *regrading* pada hasil pelaporan menggunakan kolom “Respon KMKP”



5. Tulis tanggal dan respon Komite Mutu terhadap insiden. Klik **Simpan** jika semua komentar sudah dituliskan pada kolom **Respon KMKP**. Segera *follow up* kepada kepala ruangan untuk melaksanakan respon dari komite mutu.

